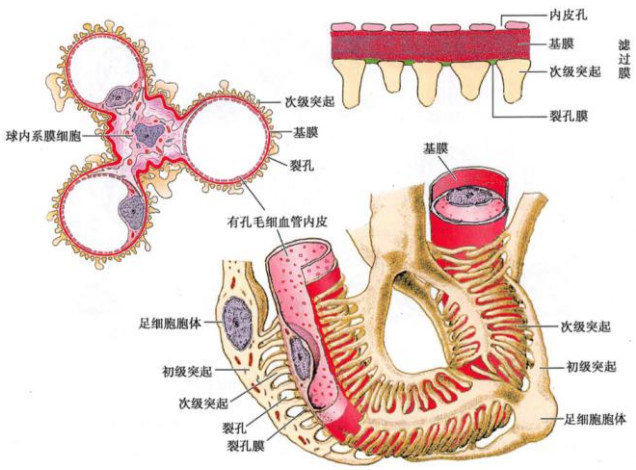
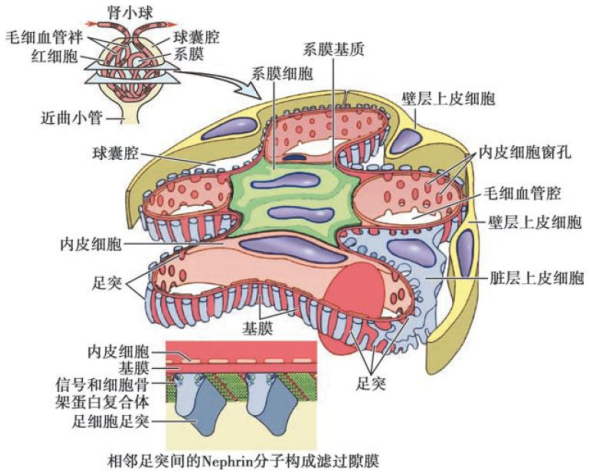




相邻足突间的Nephrin分子构成滤过隙膜

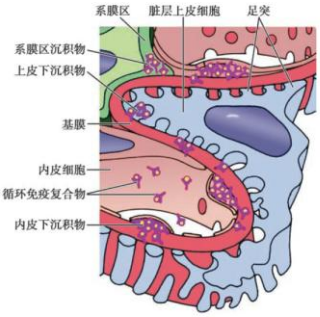
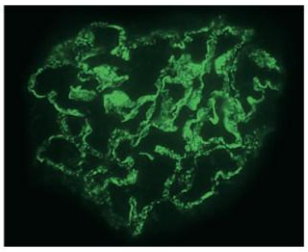


图 13-3　循环免疫复合物性肾炎示意图


图 13-4　免疫荧光染色，示不连续的颗粒状荧光

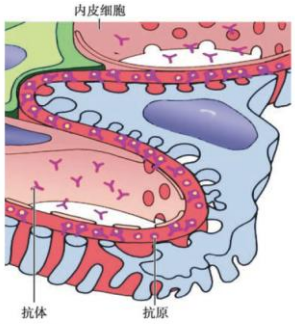
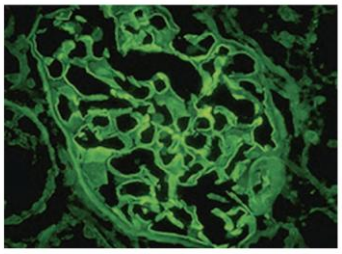


图 13-5　抗肾小球基膜抗体引起的肾炎示意图


图 13-6　免疫荧光染色，示连续的线性荧光

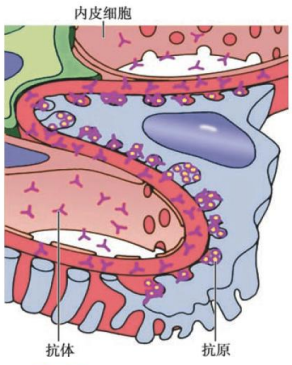


图 13-7　Heymann 肾炎示意图

系膜区：肾小球毛细血管袢之间的区域（没有被基底膜包裹）

内皮下：毛细血管内皮细胞与毛细血管基底膜之间的区域

上皮下：毛细血管基底膜与肾小囊脏层足细胞之间的区域

致密层：基底膜自身结构

三、临床分型和临床表现

（滤得过-滤过屏障受损、滤不过-有效滤过面积↓）

（一）临床分型

水钠滤不过-水钠潴留、容量依赖性高血压
滤过屏障受损-蛋白质、血细胞滤过，出现蛋白尿、血尿

急性肾小球肾炎、急进性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、无症状性血尿和/或蛋白尿、肾病综合征

注意：问临床分型只选上述 5 个。如毛细血管内增生性肾小球肾炎属于病理分型、不属于临床分型
肾穿刺活检
临床表现和病理类型不能完全划等号

e.g 脂性肾病是病理类型，主要表现是肾病综合征
系膜增生性肾炎是病理类型，主要表现是肾病综合征

（二）急性肾炎综合征

1.主要见于：急性肾炎、急进性肾炎（《病理学》中也可叫急进性肾炎综合征）、慢性肾炎急性发作

区别：
- 炎-病变累及系膜区，有较多的炎细胞参与，系膜细胞基质增生就会把基底膜扯断，就会出现血尿
- 病-不会累及系膜区